

DIABETE INSÍPIDO	
Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 17 – 05/08/2025	
Medicamento	DESMOPRESSINA
CID 10	E23.2
Apresentação	0,1 mg/mL (100 mcg/mL) aplicação nasal - frasco 2,5 mL spray 0,1 e 0,2 mg (comprimido) - Indisponível
Inclusão	Serão incluídos neste protocolo, os pacientes com diagnóstico de diabetes insípido central baseado nos seguintes critérios: • poliúria, caracterizada por um volume urinário em 24 horas acima de 3 litros (> 40 mL/kg) em adultos e adolescentes, e em crianças > 150mL/kg/dia ao nascimento, > 100mL/kg/dia em pacientes até 2 anos de idade e > 50mL/kg/dia em pacientes acima de 2 anos; E • resposta à administração de desmopressina na vigência de osmolalidade plasmática > 295 mOsm/kg ou sódio plasmático > 147 mEq/L – (10 mcg por via nasal ou 4 mcg por via subcutânea em adolescentes e adultos e 5-10 mcg por via nasal ou 1 mcg por via subcutânea em crianças), com aumento na osmolalidade urinária > 15% e osmolaridade urinária > 600 mOsm/kg.
Anexos Obrigatórios	Exames: - Osmolalidade plasmática ou sódio (Na) sérico prévio a administração da desmopressina ; - Osmolalidade plasmática e urinária (pós resposta à administração da desmopressina); - Em casos especiais e a critério médico: ressonância magnética da região hipotalâmico - hipofisária. Relato médico com diagnóstico clínico de poliúria e descartando outras formas de diabetes insípido.
Administração	Aplicação nasal: - Dose inicial: 10mcg em adultos e adolescentes e 5 mcg em crianças. - Dose de manutenção: a) solução nasal: 5 a 20mcg de 1 a 3x/dia; b) spray nasal: 10 a 20mcg de 1 a 3x/dia. - Neonatos e lactentes: dose inicialmente por via intranasal é de 2,5 mcg. Caso o recém-nascido com DI central seja prematuro ou de baixo peso, doses ainda menores podem ser necessárias. Comprimidos: Dose inicial: 0,05 a 0,1 mg/dia; Manutenção: 0,1 a 1,2 mg/dia dividido em 2 a 3x/dia.
Prescrição Máxima Mensal	8 frascos 0,1 mg (372 cp) e 0,2 mg (186 cp).
Monitoramento	Acompanhamento clínico e laboratorial. Exame de sódio plasmático com o objetivo de mantê-lo entre 137 e 145 mEq/L.
Exclusão	Pacientes com resistência, hipersensibilidade ou intolerância a desmopressina.
Tempo de Tratamento	Indeterminado.
Validade dos Exames	Osmolalidade plasmática e urinária: 6 meses. Sódio (Na) sérico: 6 meses.

Especialidade Médica	Novas Solicitações e Adequações	Endocrinologia e Nefrologia
	Renovações Sem Alterações	Endocrinologia e Nefrologia
Casos Especiais: - Pacientes com diabetes insípido gestacional que atendam aos critérios de inclusão deverão receber tratamento ao longo da gestação até a normalização do quadro. - Pacientes pós-resssecção hipofisária por tumor serão tratados se apresentarem os critérios de inclusão anteriormente referidos. - Em neonatos e lactantes o diagnóstico não requer a comprovação de poliúria, sendo feito quando o indivíduo apresentar hipernatremia (nível sérico de sódio maior ou igual a 146 mEq/L), associada a uma osmolalidade urinária inapropriadamente baixa (menor que 300 mOsm/kg), com resposta positiva ao DDAVP (osmolalidade urinária maior que 750 mOsm/kg)³⁶. Dessa forma, a limitação de aferição da diurese, própria dessa faixa etária, é eliminada, ao mesmo tempo em que o diagnóstico do DI central seria possibilitado pela utilização dos critérios laboratoriais descritos. Cálculo da Dose: - Para cálculo da dose: 10 mcg = 0,1 MI Teste de Restrição Hídrica: Em pacientes com osmolalidade plasmática acima de 295 mOsmol/kg ou sódio plasmático acima de 145 mEq/L, pode-se prescindir do teste de restrição hídrica, avaliando-se apenas a osmolalidade urinária e a resposta à administração de desmopressina. O teste de restrição hídrica deve ser finalizado quando o paciente apresentar um dos seguintes critérios: • Osmolalidade urinária > 600 Osm/kg; • Osmolalidade plasmática > 295 mOsm/kg, ou; • Sódio plasmático > 147 mEq/L. Valores de osmolalidade urinária > 600 mOsm/kg indicam adequada produção e ação do ADH e afastam o diagnóstico de diabetes insípido. Em relação à osmolalidade urinária, a resposta à administração de desmopressina costuma ser aumento de: -100 % nos pacientes com diabetes insípido central completo; -15 %-50 % nos pacientes com diabetes insípido central parcial; -10 % - 45 % nos pacientes com diabetes insípido renal parcial; -Menos de 10 % nos pacientes com diabetes insípido renal completo OBS: 1 frasco DESMOPRESSINA 0,1 mg/mL spray nasal equivale a 25 puffs. CID-10: E23.2 Diabetes insípidos		